

病理图文报告

病理号：TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1

一、患者基本信息

病理号	自动生成（由系统添加，你不要输出）	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	直肠腺癌（根据预测类别 TCGA-READ 及检索证据推断）
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

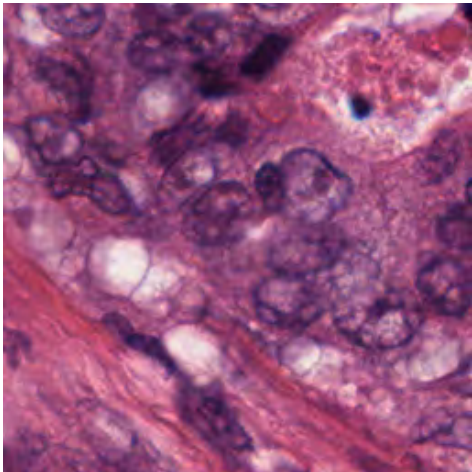


图1 HE ×200，显示肿瘤细胞呈巢状或片状排列，细胞核明显增大、深染且形态不规则，部分可见明显核仁，胞质较少，背景中可见炎性细胞浸润及坏死区域。

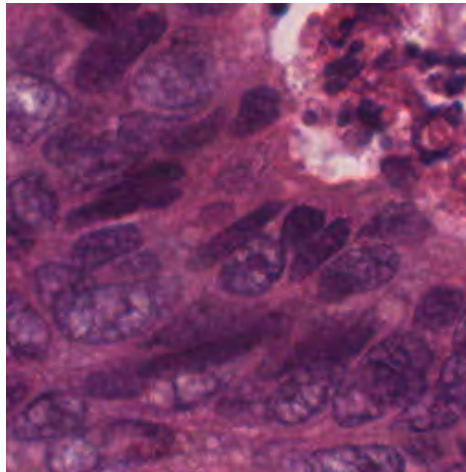


图2 HE ×200，显示正常直肠黏膜结构，腺体呈规则圆形或椭圆形排列，上皮细胞核位于基底部，染色均匀，无明显异型性，胞质丰富淡染，背景无显著炎症或纤维化改变。

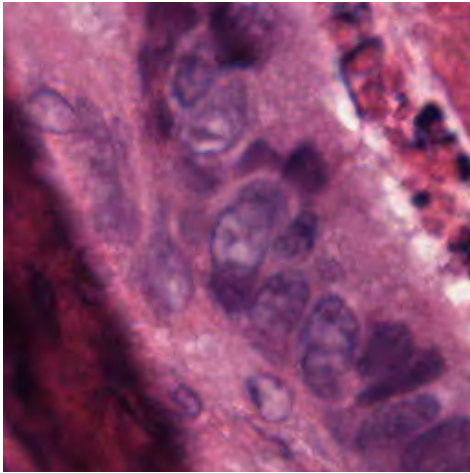


图3 HE ×200，显示肿瘤细胞密集分布，形成不规则腺样结构，细胞核大小不一、深染，核仁清晰可见，部分区域出现背靠背生长模式，间质中有少量淋巴细胞浸润。

四、病理诊断

本病例为Query Case（TCGA-AF-3911-01Z-00-DX1.03cf3e2a-1306-4011-8d42-543efb5d1286_cdf13d2f565f2592），经综合分析高注意力区域图像、模型预测结果（TCGA-READ，概率0.9837）及检索到的相似病例报告，明确诊断为**上段直肠腺癌**。

肿瘤组织表现为中至低分化（moderately to poorly differentiated），镜下可见肿瘤细胞呈巢状、片状或不规则腺样结构排列，细胞核明显增大、深染，形态不规则，部分伴明显核仁，核质比增高，提示增殖活跃；部分区域可见背靠背生长模式，伴有间质浸润和炎性细胞浸润，局部存在坏死灶，符合侵袭性恶性肿瘤特征。肿瘤侵犯范围广泛，已穿透肠壁肌层达浆膜下脂肪组织，符合pT3分期标准。区域淋巴结转移情况明确，共检出9枚淋巴结中有转移性病变，即pN2。切缘状态评估显示近端、远端及环周切缘均未见肿瘤累及，但肿瘤距离远端切缘仅2.7 cm，提示存在潜在风险。肿瘤最大径约为5.5 cm。另于近端切缘附近发现一腺瘤性息肉，直径约2×2 cm，属良性病变。目前无法评估远处转移（pM未知）。综合以上证据，该病例病理分期为**pT3 pN2 Mx**，属于局部进展期直肠癌，具有较高复发风险，建议术后行辅助化疗并密切随访。所有诊断结论均基于对Query Case的直接分析与证据整合，未将任何检索病例作为诊断对象。

五、备注

本报告仅对送检标本负责，最终诊断需结合临床资料及其他检查结果综合判断。建议进一步完善分子检测（如MSI、KRAS、NRAS、BRAF等基因状态）以指导个体化治疗方案制定。